

Gestão de Serviços de Farmácia

Flávia Deffert



Aula 03



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
EDUARDO NASCIMENTO DE ARRUDA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

A Autora

FLÁVIA DEFFERT

Olá. Meu nome é Flávia Deffert. Sou formada em farmácia pela Universidade Federal do Paraná onde, também, cursei mestrado em Ciências Farmacêuticas. Após o mestrado, pude experimentar atividades administrativas e a docência. Como experiência profissional, trabalhei na FUNTEF no setor de compras – licitações, conhecimento que depois pude aplicar na atividade como farmacêutica na FUNEAS. Atuava na direção técnica dessa fundação que é responsável pela gestão administrativa de uma série de hospitais do Estado do Paraná. Na FUNEAS, realizei atividades relacionadas a seleção, programação e aquisição de insumos e medicamentos. Para auxiliar nessas atividades, iniciei uma Pós-Graduação lato sensu em Gestão por processos e da qualidade e outra em Gestão de Serviços de Saúde, ambas na FAE Business School. Também, atuei como professora de farmacotécnica e elementos de farmacologia para o curso de farmácia e para o curso técnico em podologia, na UnC Mafra/SC e FAFILTEC Curitiba. Assim, pude perceber o quanto eu adoro exercer a minha profissão e, assim, poder transmitir conhecimento e as minhas experiências para você, que está iniciando a sua profissão. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Conhecendo o processo de seleção e padronização de medicamentos.....	10
Processo de seleção e padronização: como ocorre?	10
Seleção de medicamentos.....	14
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	18
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	23
Centro de Informações de Medicamentos (CIM).....	25
Explorando a etapa de programação.....	28
Entendendo a etapa de aquisição	35
Como comprar o que precisa?	35
Aprendendo a como e por que armazenar corretamente	44
Armazenamento e conservação	44

UNIDADE

03

INTRODUÇÃO

Que tal aprendermos sobre como selecionar, padronizar, programar, adquirir e armazenar medicamentos e produtos para saúde? Tudo isso iremos estudar nessa unidade letiva. Para isso, além do conhecimento técnico é importante que estimule o seu poder de tomada de decisão, de comunicação verbal e não verbal, liderança e poder de gerenciamento. Desse modo, por meio de uma gestão eficaz a instituição de saúde onde trabalha/lhará poderá contar com pessoal capacitado para selecionar e padronizar materiais e medicamentos que atendam às necessidades dos pacientes, que sejam estabelecidos por evidências científicas adequadas e que agradem ao corpo clínico. Além disso saberá como controlar adequadamente seu estoque e programar a compra. Como executar uma compra, em especial, saber como lidar com compras públicas. Quando essa compra chegar... o que deverá ser verificado e como armazenar? Isso também, nós iremos estudar E, aí? Prontos? Vamos lá.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Conhecer o processo de seleção e padronização de medicamentos;
2. Explorar a etapa de programação – gestão de recursos e estoque;
3. Entender a etapa de aquisição: entendendo o processo de compras;
4. Aprender por que e como armazenar corretamente.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Conhecendo o processo de seleção e padronização de medicamentos

INTRODUÇÃO:



Ao término dessa competência você conhecerá qual a importância de se realizar a seleção e a padronização de medicamentos e materiais de maneira adequada. Além disso, conhecerá a importância das Comissões de Farmácia e Terapêutica e da Comissão de Infecção Hospitalar para a realização dos trabalhos de seleção e padronização. Ao final, você estará habilitado a iniciar um processo de seleção e padronização de medicamentos e materiais. E então? Vamos lá!

Processo de seleção e padronização: como ocorre?

Vamos primeiro lembrar o conceito de farmácia hospitalar que segundo a SBRAFH (2017), é:

"A farmácia de hospitais, clínicas e estabelecimentos congêneres é uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital, adaptada e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente" (SBRAFH, 2017).

As responsabilidades da farmácia hospitalar, resumidamente, podem ser descritas como a gestão da assistência farmacêutica, gestão de produtos médico-hospitalares, implementação e monitorização de uma política interna de medicamento, gestão dos medicamentos empregados nos ensaios clínicos – se for o caso.

A SBRAFH (2017) resume as funções da farmácia hospitalar:

Na farmácia hospitalar e dos demais serviços de saúde, a provisão de produtos e serviços deve ser compreendida como meio, sendo a finalidade máxima do exercício de sua práxis o resultado da assistência prestada aos pacientes. Garantindo medicamentos seguros e necessários, quando estes são requeridos, visando sempre a efetividade da farmacoterapia e terapêutica geral, voltando-se também para o ensino e a pesquisa, propiciando assim um vasto campo de aprimoramento profissional. (SBRAFH, 2017).

O farmacêutico hospitalar deve garantir aos doentes os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor qualidade e aos mais baixos custos. A seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, a distribuição, a dispensação e o acompanhamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos devem ocorrer sob a tutela de um farmacêutico. Essas ações são realizadas por meio de estudos fármaco-econômicos que, preferencialmente, não devem sofrer influência de preferências pessoais e não respaldadas em fatos científicos.

Essas etapas compõem a assistência farmacêutica que é definida como: um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Esse conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2010).

Figura 1: Ciclo da assistência farmacêutica



Fonte: a autora (2019)

A organização da Assistência Farmacêutica, fundamentada no enfoque sistêmico, caracteriza-se por ações articuladas e sincronizadas entre as diversas partes que compõem o sistema, que influenciam e são influenciadas umas pelas outras. As atividades do ciclo da Assistência Farmacêutica ocorrem numa sequência ordenada. A execução de uma atividade de forma imprópria prejudica todas as outras, comprometendo seus objetivos e resultados.

As ações de Assistência Farmacêutica envolvem aqueles referentes à Atenção Farmacêutica, considerada como um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde. (BRASIL, 2004)

Importante lembrarmos da PNM e PNAF. A Política Nacional de Medicamentos foi aprovada, em 1998, e norteia todas as ações no que se trata os medicamentos no país. Algumas das suas diretrizes são: estabelecimento da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), regulamentação sanitária, reorientação da Assistência Farmacêutica, promoção do uso racional de medicamentos, desenvolvimento científico e tecnológico, promoção da produção de medicamentos e garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos.

Já, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica foi aprovada em 2004 pela resolução 338 do Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde é parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.

A resolução 338/2004 estabelece que a Assistência Farmacêutica deve ser compreendida como política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial e de formação de recursos humanos, dentre outras, garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve tanto o setor público como privado de atenção à saúde.

Para o nosso objetivo de estudo é, ainda, importante destacar o seguinte parágrafo contido no item "Gestão" das Diretrizes e estratégias para a organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais, aprovado pela Portaria n. 4283, de 39 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde:

Para o adequado desempenho das atividades da farmácia hospitalar, sugere-se aos hospitais que: (i) provenham estrutura organizacional e infraestrutura física que viabilizem as suas ações, com qualidade, utilizando modelo de gestão sistêmico, integrado e coerente, pautado nas bases da moderna administração, influenciando na qualidade, resolutividade, e custo da assistência, com reflexos positivos

para o usuário, estabelecimentos e sistema de saúde, devidamente aferidos por indicadores; (ii) considerem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente, bem como os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde como referência, para a seleção de medicamentos; (iii) promovam programa de educação permanente para farmacêuticos e auxiliares; (iv) incluam a farmácia hospitalar no plano de contingência do estabelecimento; e (v) habilitem a efetiva participação do farmacêutico, de acordo com a complexidade do estabelecimento, nas Comissões existentes, tais como: Farmácia e Terapêutica, Comissão Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de Ética em Pesquisa, Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e outras que tenham interface com a assistência farmacêutica hospitalar.

Destacam-se desse trecho os itens ii e v que dizem respeito, dentre outras atividades, a seleção e padronização de medicamentos.

Seleção de medicamentos

A seleção de medicamentos é o início do ciclo da Assistência Farmacêutica, pois todas as outras atividades lhe são decorrentes. É a atividade responsável pela seleção e padronização de medicamentos no estabelecimento da relação de medicamentos, sendo uma medida decisiva para assegurar o acesso aos mesmos.

A seleção dos medicamentos que farão parte do acervo medicamentoso nos sistemas de saúde é componente fundamental da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a qual possui como eixos norteadores a garantia de acesso e o uso racional dos mesmos

No ciclo da Assistência Farmacêutica, a seleção constitui o ponto de partida, sendo, portanto, uma atividade fundamental. A seleção é um processo de escolha de medicamentos

eficazes e seguros, imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma dada população, tendo como base às doenças prevalentes, com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde. (Ministério da saúde, 2010)

A seleção deve estar baseada em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos como, também, na estrutura dos serviços de saúde. É um processo dinâmico e participativo, que precisa ser bem articulado e envolver um número representativo de profissionais da área da saúde.

Juliani (2014) explica que "o processo de seleção de medicamentos deve assegurar terapêuticas racionais de baixo custo, levando-se em conta o perfil assistencial da instituição". Esse processo contínuo visa assegurar o acesso aos fármacos necessários dentro do hospital assegurando eficácia, segurança, qualidade e custos, além de incentivar o uso racional deles.

Segundo o Ministério da Saúde, as vantagens de selecionar medicamentos e materiais são:

- a. Possibilitar maior eficiência no gerenciamento do Ciclo da Assistência Farmacêutica.
- b. Disponibilizar medicamentos eficazes e seguros, voltados para as necessidades da população.
- c. Contribuir para promoção do uso racional de medicamentos.
- d. Racionalizar custos e possibilitar maior otimização dos recursos disponíveis.
- e. Permitir a uniformização de condutas terapêuticas, disciplinando o seu uso.
- f. Facilitar o fluxo de informações.
- g. Propiciar melhores condições para prática da farmacovigilância.
- h. Desenvolver e facilitar o estabelecimento de ações educativas para prescritores, dispensadores e usuários.

A principal vantagem é que por meio da seleção, pode-se escolher medicamentos seguros, eficazes e que atendam as reais necessidades da população.

Para alcançar essas vantagens, o profissional de saúde pode adotar algumas estratégias para a adoção da seleção e padronização de medicamento, como:

- a. Sensibilizar o gestor para a importância da seleção
- b. Buscar o apoio dos profissionais de saúde.
- c. Levantar as informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho.

Cavallini e Bisson (2010) complementam explicando que os medicamentos representam uma das maiores parcelas dos custos hospitalares. A racionalização dos gastos com medicamentos garante que o usuário receba a melhor terapêutica ao menor custo, de acordo com a realidade nacional.

A partir da seleção visa-se realizar a padronização dos medicamentos em ambiente hospitalar. Assim, constituindo uma relação básica de produtos que atendam aos critérios propostos pelo Ministério da Saúde.

Constituindo os estoques das farmácias hospitalares, esse tipo (*de medicamentos padrão*) de relação objetiva o atendimento médico-hospitalar de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada instituição. Assim, os itens selecionados devem ser de amplo aproveitamento, desde que seja de forma equilibrada e qualitativo (Cavallini e Bisson, 2010).

As principais vantagens que a padronização de medicamentos traz são:

- Reduzir o custo de terapêutica sem prejuízos para a segurança e a eficácia dos medicamentos;
- Racionalizar o número de medicamentos, reduzindo custos de aquisição do arsenal terapêutico;
- Facilitar as atividades de planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e controle dos medicamentos;
- Disciplinar o receituário médico-hospitalar e uniformizar a terapêutica;

- Aumentar a qualidade da farmacoterapia e facilitar a vigilância farmacológica;
- Disciplinar a inclusão e/ou exclusão de medicamentos quando necessário;
- Possibilitar o uso de uma mesma linguagem (nome genérico);
- Propiciar a sistematização de informações.

Isso tudo é principalmente importante dado ao grande leque de medicamentos disponíveis, mas que não necessariamente significa vantagens a uma população uma vez que pode se tornar confuso e um desperdício de recursos humanos e de dinheiro.

As etapas de seleção de medicamentos são importantes e devem ser seguidas para que o processo de seleção de medicamentos seja efetivo, garantindo a adesão dos funcionários de todos os setores do hospital.

Juliani (2014) explica que primeiro deve haver a formação de uma comissão de seleção de medicamentos. Essa deve designar uma comissão de seleção de medicamentos que irá atuar ativamente no processo. Essa comissão deverá realizar o levantamento do perfil posológico, analisar o nível assistencial e a infraestrutura de tratamento do hospital, analisar o padrão de utilização de medicamentos já existente no hospital, determinando o perfil dos prescritores e os medicamentos essenciais. Então, ela irá definir os critérios de seleção dos medicamentos que serão adotados e fazer a seleção propriamente dita dos mesmos. Por fim, realizará a elaboração da lista de medicamentos e divulgará a todo corpo clínico.

No entanto, a seleção e padronização de medicamentos não é uma tarefa fácil, tendo em vista que precisa agradar o maior número de gregos e de troianos. Além de que, se não agradar, deve-se ao menos convencê-los a usar. Juliani (2014) destaca que "a lista de medicamentos padronizados em uma instituição deve ser amplamente divulgada para os profissionais atuantes no corpo clínico, com intensidade e continuidade, para garantir o uso racional dos medicamentos".

Para tanto duas comissões ganham destaque nessa tarefa: Comissão de Farmácia e Terapêutica e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Lembre-se que além dessas o farmacêutico ainda pode e/ou é obrigado a participar nas seguintes comissões: comissão de controle de qualidade de materiais, comissão de gerenciamento de risco e segurança do paciente, comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, comissão de gestão da qualidade, comissão de suporte nutricional e enteral, comissão de ética, comissão de ensino e pesquisa, comissão de prontuário, comissões de auditorias internas, comissões clínicas, comissão de lesões, comissão de materiais esterilizáveis, comissão de biossegurança.

Importante destacar que o profissional que participa desse tipo de tarefa deve apresentar algumas características e outras competências aprimoradas, são elas:

- Saber conviver em grupo;
- Respeitar as identidades e as diferenças;
- Inter-relacionar pensamentos, ideias e conceitos;
- Disposição para aprender;
- Conhecimento técnico referente à área de atuação;
- Conhecimento da legislação específica;
- Domínio da leitura e interpretação de artigos científicos;
- Domínio de técnicas para elaboração de relatórios;
- Conhecimento de comunicação e de informática;
- Maturidade institucional;
- Saber agir diante das oportunidades e associá-las às metas institucionais;
- Utilizar conhecimentos técnicos para a implantação de ações que garantam a melhoria dos cuidados oferecidos aos pacientes;
- Identificar mudanças nos cenários e associá-las às necessidades de rever os projetos e ações;
- Elaborar e implantar projetos com coerência, respeitando a realidade da instituição;
- Elaborar e analisar relatórios com destreza, utilizando-os para melhoria dos processos administrativos e assistenciais.

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)

A CFT tem uma atuação fundamental para a garantia do uso racional de medicamentos no hospital. Essa comissão, por meio

de processo multidisciplinar, estabelece as políticas e práticas que envolvam e estimulem o uso racional de medicamentos. Ou seja, a CFT é a junta deliberativa designada pela diretoria clínica com a finalidade de regulamentar a padronização dos medicamentos utilizados no receituário hospitalar.

Seu objetivo é padronizar o elenco de medicamentos; divulgar, alterar e elaborar estudos; registrar informações e manter arquivo da documentação pertinente. No processo de seleção, devem ser consideradas as diversas ciências farmacêuticas como farmacoeconomia, farmacoepidemiologia, farmacologia e terapêutica clínica, farmacovigilância, biofarmacotécnica e farmacocinética.

A frequente introdução de novos medicamentos e o uso da alta tecnologia na medicina são fatores que contribuem para a elevação dos custos de assistência à saúde. É necessário que esses novos medicamentos e tecnologias sejam estudados e que seja avaliada sua real efetividade para que, então, possam ser incluídos no uso hospitalar, garantindo a utilização racional desses recursos. (Juliani, 2014)

De acordo com Cipriano et al (2011) a CFT deve adotar critérios para seleção e padronização dos medicamentos/produtos farmacêuticos, como:

- a. registro no país em conformidade com a legislação sanitária;
- b. necessidade segundo aspectos clínicos e epidemiológicos;
- c. valor terapêutico comprovado, com base na melhor evidência científica em seres humanos, destacando segurança, eficácia e efetividade, com algoritmo de escolha (fluxograma) de tratamento definido;
- d. composição com única substância ativa, admitindose, apenas em casos especiais, associações em doses fixas;
- e. o princípio ativo conforme Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua ausência, Denominação Comum Internacional (DCI);
- f. informações suficientes quanto às características farmacotécnicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas;
- g. preço de aquisição, armazenamento, distribuição e controle;

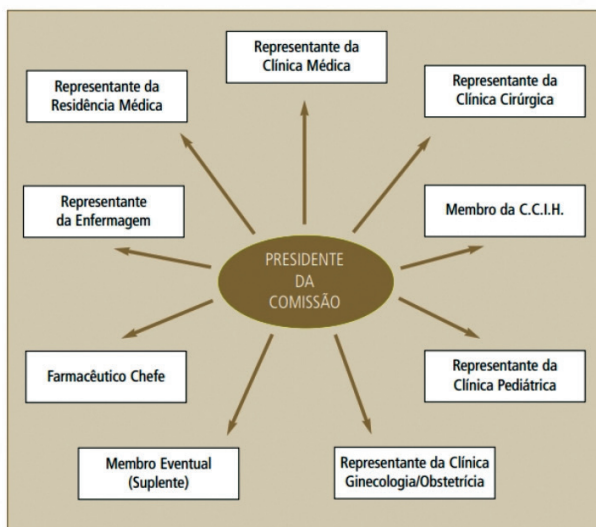
h. menor custo do tratamento/dia e custo total do tratamento, resguardando segurança, eficácia, efetividade e qualidade de vida;

i. concentração, forma farmacêutica, esquema posológico e apresentação, considerando a comodidade para a ministração aos pacientes, faixa etária, facilidade para cálculo de dose a ser ministrada e de fracionamento ou multiplicação de doses, bem como perfil de estabilidade mais adequado às condições de armazenamento e uso.

Essa comissão deve ser constituída por: farmacêutico, médico, enfermeiro, odontólogo. Cavallini e Bisson (2010) ainda sugerem que essa comissão deve ser constituída por:

- um (1) farmacêutico – chefe da Farmácia ou farmacêutico por ele indicado, que atuará como membro nato;
- um (1) médico – representante da Clínica Médica;
- um (1) médico – representante da Clínica Cirúrgica;
- um (1) médico – representante da Pediatria;
- um (1) médico – presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (C.C.I.H.) ou médico por ele indicado;
- um (1) enfermeiro – chefe de Enfermagem ou enfermeiro por ele indicado.

Figura 2: Representação gráfica da estrutura organizacional da CFT



Fonte: Cavallini e Bisson (2010)

A composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica possui característica multiprofissional e depende da disponibilidade dos recursos humanos existentes na instituição. Essa formação deve ser formalmente descrita por meio de um documento legal e é necessário elaborar um regimento interno que normatize o seu funcionamento.

Além dos membros obrigatórios, a comissão ainda pode contar com assessores de fora da comissão para auxiliar na tomada de alguma decisão de assunto específico. É importante que todos os membros sejam competentes tecnicamente e contar com conhecimento farmacológico, terapêutico, clínica médica e de economia em saúde.

Cipriano et al (2011) explica que essa comissão tem as competências:

- a. Assessoramento farmacoterapêutico
 - Seleção e padronização dos medicamentos;
 - Elaboração e atualização do Guia Farmacoterapêutico;
 - Definição de diretrizes para o uso racional dos medicamentos;
 - Elaboração de normas para prescrição, dispensação e uso de medicamentos;
 - Avaliação para incorporação de novas tecnologias;
 - Promoção e elaboração de Protocolos Clínicos de tratamento.
- b. Investigação científica
 - Promoção de estudos de utilização de medicamentos e de farmacoeconomia para analisar o perfil farmacoepidemiológico e de impacto econômico dos medicamentos nas instituições da saúde;
 - Atividades voltadas ao gerenciamento de riscos e farmacovigilância (queixas técnicas, reações adversas ao medicamento e erros de medicação).
- c. Ações educativas
 - Desenvolvimento e apoio às ações de promoção do uso racional de medicamentos;
 - Colaboração e participação em atividades de educação permanente da equipe da saúde;
 - Elaboração e divulgação de instrumentos educativos, utilizando os meios de comunicação;
 - Incentivo e realização de campanhas para práticas seguras do uso do medicamento.

De acordo com Ciprani et al (2011), as reuniões da CFT podem ser descritas de modo genérico como:

- verificação da presença do Presidente e, em caso de sua ausência, abertura dos trabalhos pelo Vice-Presidente;
- verificação de presença dos membros e existência de "quórum";
- aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;
- leitura e despacho do expediente;
- apresentação de assuntos por convite dos externos;
- leitura da Ordem do Dia, seguida por discussão e votação;
- encaminhamento das deliberações para Diretoria Clínica;
- organização da pauta da próxima reunião;
- encerramento dos trabalhos.

Nesse contexto, Cavallini e Bisson (2010) e Cipriano et al (2011) explicam as atribuições dos principais cargos na CFT:

- **Presidente:** convocar e presidir reuniões da comissão; dirigir os trabalhos da comissão; indicar seu substituto entre os membros da comissão; representar a comissão perante a diretoria clínica; subscrever os documentos e as resoluções da comissão; estabelecer a ordem do dia para as reuniões ordinárias e extraordinárias; distribuir as tarefas para os membros da comissão;

- **Secretário:** registrar em atas as resoluções da comissão; receber e expedir a documentação da comissão; manter arquivo de documentação; registrar em fichas individualizadas, para cada medicamento padronizado, informações pertinentes às ocorrências relativas a seu uso; e,

- **Membros de Comissão:** comparecer às reuniões convocadas; colaborar com os trabalhos da comissão quando solicitado pelo presidente.

Após a seleção do arsenal terapêutico pela comissão, a proposta deverá ser aprovada pelo corpo clínico, podendo ser realizada por meio de um questionário, como o sugerido a seguir. Essa fase é chamada de pré-padronização. Além disso, deve-se estabelecer uma rotina para a aquisição de medicamentos não padrão, cujo uso deve ser estritamente EVENTUAL.

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Vamos, brevemente, falar do porquê da existência dessa comissão.

Antimicrobianos são produtos capazes de destruir micro-organismos (sufixo - cida) ou de suprimir sua multiplicação e crescimento (sufixo - stático). A antibioticoterapia, portanto, é o tratamento de pacientes com sinais e sintomas clínicos de infecção pela administração de antimicrobianos.

O princípio básico da terapia anti-infecciosa é a determinação do agente causal da infecção e de sua suscetibilidade aos antimicrobianos. Como regra, o diagnóstico de infecção deve ser embasado em resultados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais.

Porém sabemos que, apesar dos esforços, o uso de antimicrobianos é superior ao que deveria ocorrer. Por experiência própria posso contar um caso:

Mulher, 25 anos, com dor de cabeça; dor no corpo; coriza; espirros; febre baixa (37,5 – 38°C) – temperatura média normal da paciente é 35,5 – 36°C; mal-estar e enjoo. Se dirige ao pronto socorro de um hospital particular por insistência da família, já que fazia mais de um mês que estava "gripada".

Passa pela triagem – medição dos parâmetros vitais pela enfermagem e é chamada pelo profissional.

Após contar seus sintomas, o profissional – sem tocar em nenhuma parte da paciente – diz: é somente um resfriado, vou te receitar um antibiótico para prevenir uma gripe.

A pessoa que vos fala pega a receita de amoxicilina + clavulanato (875 mg+ 125 mg) e paracetamol (500 mg), se febre, e vai embora incrédula. Além de mal realizar a anamnese, o profissional prescreveu antibiótico sem nem olhar a garganta para verificar alterações que indiquem infecção e/ou inflamação e para prevenir gripe – gripe é uma doença viral, ou seja, não é prevenida por um medicamento que causa a morte de bactérias. Isso ainda tem um agravante, a presença do clavulanato indica que o medicamento é empregado para bactérias resistentes, que produzem beta-lactamases.

O uso indiscriminado de antibióticos promove a seleção natural de bactérias ainda mais resistentes. Por isso, a maior parte das bactérias já

são resistentes a pelo menos um antibiótico. Isso promove nas instituições de saúde muitos casos de infecção hospitalar que é definida como qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente no hospital e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando pode ser relacionada com a internação ou com os procedimentos hospitalares.

Cavallini e Bisson (2010) explicam que:

A maioria das infecções hospitalares tem origem endógena, em razão do desequilíbrio da relação que o homem estabelece com sua microbiota, o que é favorecido pela patologia de base, utilização de procedimentos invasivos e pressão seletiva em favor dos germes resistentes, exercida pelos antibióticos. A infecção exógena é limitada pela pequena capacidade que essa microbiota apresenta de sobrevivência no meio ambiente, na ausência de matéria orgânica que favoreça sua proliferação, sobretudo de sangue, secreções e excretas eliminados pelos pacientes. (Cavallini e Bisson, 2010)

Para que isso seja controlado em ambiente hospitalar, principalmente, nos pacientes de alto risco – em especial àqueles internados por longos períodos. Dessa forma, a CCIH em conjunto à CFT, devem ser responsáveis por:

- padronizar os antimicrobianos em uso na instituição (de acordo com critérios preestabelecidos);

- estabelecer o controle permanente da prescrição de antimicrobianos no hospital, principalmente para as cefalosporinas de 3ª e 4ª gerações, aminoglicosídeos, quinolonas, novos betalactâmicos

A Lei Federal n. 6.431, de 6/1/1997, obrigou a existência de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e de um Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH). Esse programa pode ser definido como um conjunto de ações, desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com o objetivo de reduzir, ao máximo possível, a incidência e a gravidade das infecções. Em 1998, o Ministério da Saúde fixou a Portaria n. 2616/98 que ditou as diretrizes e normas para a execução dessas ações.

Os membros da CCIH devem ser divididos em consultores e executores, sendo os últimos responsáveis pelo PCIH, substituindo o antigo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). As atribuições da CCIH são:

- atualizar-se teoricamente sobre o tema, para oferecer respaldo científico legal a toda a comunidade hospitalar;
- avaliar todos os cuidados prestados, direta ou indiretamente, ao paciente, a fim de identificar problemas e apontar soluções;
- medir o risco de aquisição de infecção hospitalar, avaliando prioridades para seu controle e auxiliando toda a comunidade hospitalar na aplicação de recursos técnico-financeiros;
- verificar a necessidade de programas educativos e colaborar em sua execução;
- intermediar as relações do hospital com as autoridades sanitárias.

A escolha e o controle dos antimicrobianos empregados em ambiente hospitalar, bem como a padronização de procedimentos terapêutico, traz maior segurança a paciente além de ser uma medida de racionalização de custos, melhora na lucratividade e cumprimento com exigências legais, morais e éticas.

Centro de Informações de Medicamentos (CIM)

Para auxiliara escolha e tirar dúvidas sobre os medicamentos utilizados na instituição, faz-se necessário que os profissionais que compõe a farmácia hospitalar sejam instruídos e capazes de instruir a equipe de saúde com a finalidade de promover a assistência terapêutica, a educação continuada e apresentar dados importantes sobre os medicamentos e produtos de saúde. Dessa forma, promovendo o uso racional de medicamentos.

O Centro de Informação de Medicamentos é o local onde se realiza a seleção, a análise e a avaliação das fontes de informação sobre medicamentos, permitindo a elaboração e a comunicação de informações corretas para os profissionais da saúde (Cavallini e Bisson, 2010). As informações podem ser obtidas de fontes primárias, secundárias ou terciárias.

- Fonte Primária: documentos adquiridos pelo próprio autor;
- Fonte Secundária: documentos que apresenta citações de pesquisas primárias;

■ Fonte terciária: documentos que apresentam dados de pesquisas primárias e secundárias.

Hoje, o padrão ouro de fonte de informações são as revisões sistemáticas com análises estatísticas que revelem a correlação e a relevância das informações – revisões sistemáticas com meta-análise, por exemplo.

A representação gráfica apresenta a pirâmide dos níveis evidências científicas atualmente aceita. Lembre-se dela quando for realizar as suas pesquisas, ok?

Figura 3: Representação gráfica dos níveis de evidência científica



Fonte: autora, 2019

Para saber mais sobre saúde baseada em evidências consulte o Portal Saúde Baseada em Evidências (PSBE) que é uma ação do Ministério da Saúde, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (Capes/MEC). Essa plataforma do MS disponibiliza aos profissionais de saúde acesso rápido e fácil a conteúdos e evidências cientificamente revisadas. Essas informações, providas de evidências científicas, são utilizadas pelos profissionais de saúde para apoiá-los na prática clínica e na tomada de decisão na gestão em saúde e qualificação do cuidado, bem como nos processos de ensino-aprendizagem, fortalecendo a integração ensino-serviço-comunidade.



ACESSE:

Consulte o folder sobre o Portal Saúde baseada em evidências por meio do link: <http://bit.ly/2uxuzXg>

Ainda, segundo esses autores as principais rotinas do CIM consistem em: estudos de utilização de medicamentos; dar subsídios às ações da CFT; guia farmacoterapêutico; boletins informativos; critérios de uso de medicamentos; elaboração de um banco de dados sobre medicamentos; cadastramento de fornecedores; eventos no âmbito da farmácia hospitalar, visando à revisão ou à atualização dos funcionários; participação em grupos de apoio.

As principais dificuldades encontradas pela equipe consistem na falta de preparo da equipe, principalmente, sobre fontes de conhecimento; falta da adesão da equipe multiprofissional do hospital; escassez de modelos de implantação; falta de informações de medicamentos patenteados ou em pesquisa clínica; presença de um corpo clínico essencialmente aberto; ausência de integração profissional; e, prontuários médicos com falta de informações, mesmo aqueles automatizados.

Como pode perceber, a seleção e a padronização de medicamentos são tarefas difíceis de fazer uma vez que envolve fatores humanos, políticos e econômicos, quando na realidade deveria basear-se, somente, em evidências científicas.

REVISANDO:

Gostou dessa nossa competência? Lembra o que vimos? Vamos dar uma revisadinha. Nessa competência vimos como a seleção de medicamentos se encaixa no ciclo da assistência farmacêutica. Além disso, estudamos a sua importância e objetivos que, dentre eles, está estabelecer uma lista de medicamentos padrão. A lista padronizada deve ser estabelecida por uma comissão de padronização que deve abranger, minimamente, a equipe multiprofissional da CFT e da CCIH. Por fim, estudamos a importância de se ter um CIM e que nele podem se concentrar esforços para reunir informações que servem como subsídio para a CFT e CCIH, como também para sanar dúvidas da equipe multidisciplinar do hospital. Pronto para próxima?



Explorando a etapa de programação

A programação é a segunda etapa do ciclo da assistência farmacêutica e baseia-se nas escolhas realizadas na primeira etapa. Se essa etapa já está bem estabelecida, o ponto de partida se torna o estoque que já está presente.

O Ministério da Saúde define que programar medicamentos consiste em estimar quantidades a serem adquiridas, para atender determinada demanda de serviços, em um período definido, possuindo influência direta sobre o abastecimento e o acesso ao medicamento.

Dessa forma, a programação visa identificar as quantidades de medicamentos necessárias ao atendimento da demanda da população; evitar compras e perdas desnecessárias, assim como descontinuidade no suprimento; definir prioridades dos medicamentos a serem adquiridos, frente à disponibilidade de recursos.

Para que a programação de compras possa ser feita são necessários dados sobre consumo, demanda, estoque existente, perfil epidemiológico, dados de atendimentos (perfis ao longo do ano), recursos financeiros disponíveis e mecanismos de controle e acompanhamento.

Juliani (2014) explica: o alto custo dos medicamentos faz com que haja a necessidade de controle visando à redução dos custos finais, sem prejuízo na assistência ao paciente.

A previsão de estoque tem características básicas:

- é o ponto de partida de todo o planejamento do estoque;
- Depende da eficácia dos métodos empregados;
- Depende da qualidade das hipóteses aplicadas para o raciocínio (Cavallini e Bisson, 2010).

O controle de estoque deve ser realizado com cuidado, de modo a garantir o atendimento contínuo às necessidades do hospital e evitando compras de emergência, perdas por vencimento, danos aos materiais estocados etc.

Os cálculos para verificar os níveis de estoque são essenciais para tomadas de decisão. Para isso, é importante determinar alguns índices, conforme explicações de Cavallini e Bisson, 2010:

- Consumo Médio Mensal (CMM): quantidade referente à média aritmética das retiradas mensais do estoque (devem ser utilizados os valores relativos a, no mínimo, os últimos seis meses).

■ **Estoque Médio:** nível médio de estoque em torno do qual as operações de compra e consumo se realizam. Esse índice é calculado pela multiplicação do CMM por um fator de segurança arbitrário que é considerado pelo gestor como uma garantia contra faltas ou rupturas.

■ **Intervalo de Suprimento:** intervalo entre dois suprimentos (depende das quantidades compradas, do tempo de entrega dos fornecedores e do consumo médio).

■ **Estoque Mínimo ($E_{\min}$):** também chamado de estoque de segurança, é a quantidade mínima que deve ser mantida em estoque; destina-se a cobrir atrasos no suprimento, de modo que se garanta o funcionamento ininterrupto do processo produtivo, sem o risco de faltas.

■ **Rotatividade:** significa quantas vezes foi necessário retomar o estoque de um item, sendo calculado pela divisão de CMM para 12 meses pelo estoque médio. Não se deve utilizar a mesma taxa de rotatividade para materiais de preços muito diferenciados. Usar, de preferência, a Classificação ABC.

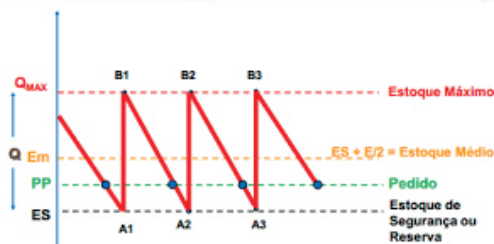
■ **Estoque Máximo ($E_{\max}$):** soma do estoque mínimo com o lote de compra.

■ **Tempo de Reposição (TR):** intervalo de tempo entre a emissão do pedido e a chegada do material ao estoque.

■ **Estoque Disponível:** estoque existente (físico) mais os fornecimentos em atraso e em aberto.

■ **Ponto de Pedido (PP):** ponto em que se verifica se o saldo disponível está abaixo ou igual a certa quantidade, que determina a necessidade de um novo suprimento. O ponto de pedido é calculado pelo CMM multiplicado pelo TR e somado ao estoque mínimo.

Figura 4: Gráfico de Ponto de Pedido ou de Dente de Serra



Existem alguns fatores que podem alterar abruptamente o estoque que são as oscilações de consumo e no tempo de reposição, além da entrega de produtos com especificações diferentes do solicitado e erros de inventário.

Para evitar que a ruptura ocorra existem diversos métodos para programar medicamentos, sendo que, os mais comuns e utilizados são: perfil epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços. Para isso, o Ministério da Saúde recomenda utilizar a combinação de diversos métodos, para que se consiga uma programação com melhores resultados.

■ **Perfil epidemiológico:** baseia-se no perfil nosológico e nos dados de morbimortalidade, considerando: dados populacionais, esquemas terapêuticos existentes e com que se apresentam as diferentes enfermidades em uma determinada população.

As vantagens desse método são que não requer dados de consumo e é aplicável quando não é aplicável quando não se dispõe de informações sobre a utilizações de medicamentos ou quando da implantação de novos serviços. Contudo, a confiabilidade dos dados utilizados é duvidosa e pode acarretar uma programação superestimada.

■ **Consumo histórico:** é a análise do comportamento de consumo de medicamentos durante um período. Para o cálculo do consumo histórico consideram-se os registros de movimentação de estoques, dados de demanda (atendida e não atendida), inventários com informações de, pelo menos, 12 meses, incluídas as variações sazonais (que são alterações na incidência das doenças, decorrentes das estações climáticas).

Apesar de ser melhor do que considerar o perfil epidemiológico isoladamente, se forem considerados somente os dados de consumo pode-se haver erros decorrentes da dificuldade de obter dados, de fato, reais de consumo e podem ser afetados por períodos de desabastecimento ou por uso errôneo de medicamentos.

A principal vantagem desse método é que os cálculos são simples. Vamos ver:

a. **Consumo médio mensal ou média móvel:** É a soma dos consumos de medicamentos utilizados em determinado período, dividido pelo número de meses em que cada produto foi utilizado. Excluir perdas, empréstimos e outras saídas não regulares.

Por exemplo:

	Jan	Fev.	Mar	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Ago.	Set	Out	Nov.	Dez
Ampicilina susp. Oral 50 mg/mL	75	50	15	15	15	20	15	20	15	15	60	70

$$CMM = \left(\frac{\text{consumo}}{\text{período}} \right)$$

$$= \frac{75 + 50 + 15 + 15 + 15 + 20 + 15 + 20 + 15 + 15 + 60 + 70}{12}$$

$$= 32,1 \text{ frascos por mês em um período de 12 meses}$$

Alguns conceitos devem ficar claros:

- Consumo: quantidade de medicamentos utilizados nos serviços de saúde de uma determinada localidade em intervalos de tempo;
- Necessidade: É uma quantidade de medicamentos prevista em função do perfil epidemiológico, que varia de acordo com a oferta e com o nível de complexidade dos serviços de saúde;
- Demanda total ou real: é a soma da demanda atendida e a não atendida;
- Demanda não atendida: quantidade prescrita e não atendida. É calculada pela divisão do número de dias que o medicamento faltou pelos dias de funcionamento da unidade. O resultado dessa divisão é multiplicado pelo CMM;
- Oferta de serviços: utilizado quando se trabalha em função da disponibilidade de serviços ofertados à população-alvo.

É importante lembrar que todo e qualquer armazenamento de material gera determinados custos com juros; depreciação; aluguel; equipamentos de movimentação; deterioração; obsolescência; seguros; salários; conservação. Além disso, a quantidade estocada e o tempo de permanência em estoque podem aumentar os chamados custos de armazenagem. Outros métodos que devem ser utilizados para o controle de estoque são a classificação ABC e a classificação XYZ.

A classificação ABC ou Pareto ou classificação 80-20 possibilita ao farmacêutico gestor de estoques individualizar a atenção para cada grupo de medicamentos. É um procedimento que visa a separar os produtos em grupos com características semelhantes, em função de valores e consumos, a fim de proceder a um processo de gestão apropriado a cada grupo.

Esse tipo de curva é obtido pela ordenação dos itens conforme sua importância relativa. A curva ABC tem sido usada para a administração de estoques, a definição de política de vendas, o estabelecimento de prioridades para a programação da produção e uma série de outros problemas comuns em uma empresa.

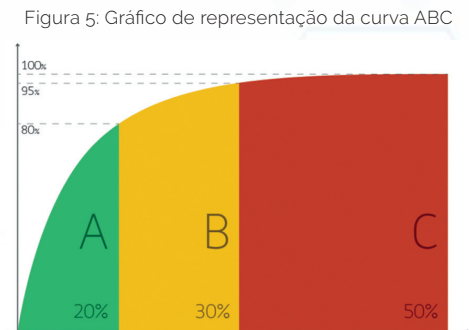
Cavallini e Bisson (2010) descrevem as classes como:

Classe A: grupo de itens mais importantes, que devem ser tratados com atenção especial pela administração, representam 8% dos itens e correspondem a 70% do custo total (quantidade pequena e alto custo unitário).

Classe B: itens em situação intermediária entre as classes A e C; representam 20% dos itens e correspondem a 20% do custo total.

Classe C: itens menos importantes, que não justificam grande atenção por parte da administração; representam 72% dos itens e correspondem a 10% do custo total (exatamente o contrário da curva A: quantidade grande e pequeno custo unitário).

Essa classificação pode ser representada por uma curva gráfica que é conhecida como curva ABC.



Fonte: <http://bit.ly/3c62uad>

Além da classificação ABC, a classificação XYZ também é empregada para o controle de estoque e a veremos adiante.



SAIBA MAIS:

Para saber como calcular e mais detalhes sobre a classificação ABC, aconselho o link: <http://bit.ly/3a2FOWB>

O site da Endeavor é uma plataforma presente em mais de 30 países e tem como missão multiplicar o poder de transformação dos empreendedores. Nesse site, há diversos artigos elaborados por seus colaboradores e que podem auxiliar no seu dia-a-dia.

Enfim, a Curva ABC pode ser utilizada para estoque ou consumo, sendo uma ferramenta fundamental para a gestão dos insumos farmacêuticos.

A classificação XYZ é explicada pelo CRF/PR (2012) como a curva que classifica os produtos segundo a prioridade técnica:

■ "X" os medicamentos necessários mais que não são imprescindíveis para a realização de um procedimento ou terapia e que geralmente possuem substitutos ou equivalentes;

■ "Y" são os medicamentos essenciais cuja falta pode provocar alteração momentânea no processo de rotina, podendo paralisar ou reduzir algumas atividades e, em alguns casos, possuem substitutos ou equivalente; e,

■ "Z" cuja falta pode prejudicar a realização de processos vitais, são os medicamentos considerados essenciais.

A combinação dos sistemas ABC e XYZ pode ser bastante útil para uma programação mais ajustada e pode auxiliar na tomada de decisão em relação a prioridade.

Figura 6: Matriz para análise da união de dados obtido pela classificação ABC e XYZ

Exp.(123)	P	Q	R	
X	A	A	C	• Capital Empregado – X para os com maior volume, Y médio volume e Z baixo volume. • Frequência de utilização – P para os utilizados todos os meses, Q média frequência e R baixa frequência. • Exposição ao Risco – 1 para Alta concentração de fornecedores, 2 para média e 3 para baixa.
Y	B	B	C	
Z	C	C	C	

Fonte: <http://bit.ly/2vegBd7>

O Tribunal de Contas da União (2015) resume essa etapa como a fase cujo objetivo é definir os quantitativos do medicamento selecionado que devem ser adquiridos, de acordo com os recursos disponíveis, de modo a evitar a descontinuidade do abastecimento. Para isso, é necessário avaliar a situação local de saúde; o nível de acesso dos usuários aos medicamentos; o perfil de doenças da população; as metas de cobertura e oferta de serviços e a disponibilidade orçamentária e financeira. A implantação de um bom sistema de controle de estoques, prevendo os recursos financeiros e orçamentários a serem empregados deve ser um dos objetivos do gestor em saúde para uma boa administração de recursos. O resultado da programação bem executada é poder dispor dos medicamentos selecionados, nas quantidades necessárias e no tempo oportuno, o que exige a organização de uma logística eficiente.

O controle de estoque é essencial para que a programação das compras seja bem-feita, por isso, esse assunto foi tratado no tópico programação e, não, na etapa de armazenamento. É importante lembrar que para uma correta fonte de informações sobre os produtos é vital a implantação de um sistema informatizado de controle de estoque.

RESUMINDO:

Compreendeu tudinho? Nessa competência exploramos a programação de compras de medicamentos e produtos para saúde. Vimos como pode ser calculado o consumo e como avaliar a importância de cada item no total de itens que compõe a lista de medicamentos padrão do hospital. A análise dos itens presentes no estoque é feita por uma série de índices e pode ser representada, item a item, pelo gráfico de ressuprimento ou dente de serra. Além disso, os itens podem ser classificados pela curva ABC e pela XYZ, podendo ser empregado para tomada de decisões. Os métodos de cálculo podem ser por perfil epidemiológico, como também pelo consumo histórico. Todos os resultados devem ser unidos para uma melhor manutenção de níveis ótimos de estoque.



Entendendo a etapa de aquisição



INTRODUÇÃO:

E aí? Pront@ para mais uma etapa da assistência farmacêutica? Nessa competência iremos entender a etapa de aquisição. Essa etapa é especialmente complicada nos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Isso porque a essas compras devem ser realizadas por modalidades de licitação e boa parte das vezes o executor da licitação não possui o conhecimento técnico do medicamento ou material médico; enquanto o requerente da compra não faz nem ideia de como se dá uma compra pública. Vamos ver se com a minha experiência de pregoeira e de solicitante da compra posso fazer com que você consiga entender isso tudinho. Vamos lá?

Como comprar o que precisa?

A etapa de aquisição tem a função de suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades corretas. A maioria dos hospitais utiliza para aquisição de insumos farmacêuticos dados de consumo histórico, mas é importante lembrar que todos os métodos de previsão de compras apresentam falhas, então, o mais correto é que se una essas informações para a tomada de decisão.

O CRF/PR (2012) explica que a aquisição de medicamentos é o ponto fundamental na atividade da gestão da assistência farmacêutica. Para isso é importante que o setor de compras da instituição de saúde esteja em consonância com os setores assistenciais.

Os objetivos desse setor devem ser, segundo Cavallini e Bisson (2010):

1. Manter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender à demanda.
2. Coordenar o fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento, sem afetar a operacionalidade da empresa.
3. Comprar materiais e insumos pelos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos.

4. Procurar, sempre dentro de uma negociação justa e honesta, as melhores condições para a empresa, sobretudo quanto a condições de pagamento.

Para definir o que deve ser comprado, aliada a todas ferramentas para a etapa de programação, o método 5W2H é aconselhado por diferentes autores, incluindo o CRF/PR (2012). O significado dessas siglas é:

- Who: quem compra? - Capacitação e treinamento da equipe, pois a definição de um fluxo operacional para o processo de compras, com atribuições e responsabilidades agiliza o processo;

- What: o que compra? - Itens padronizados pela CFT

- How many: quanto compra? When: quando compra? Why: por que compra? - controle de estoque, isto é, dados estabelecidos pela etapa de programação: ponto de compra para reposição de estoques seguindo planejamentos e estratégias com avaliação criteriosa das curvas ABC e XYZ

- Where: onde compra? Seleção e qualificação de fornecedores que atendam todos os requisitos legais de documentação e autorizações de fabricação e comercialização. O CRF/PR sugere observar minimamente a seguinte documentação: Cadastro de Fornecedor (endereço); Autorização de funcionamento emitida pela Anvisa; Licença Sanitária atualizada; Autorização de comercialização (Distribuidoras); Registro da Empresa e do Produto no Ministério da Saúde; Visita Técnica; Certificado Regularidade-responsabilidade técnica; Certificado Boas Práticas de Fabricação; Certificado Boas Práticas de Armazenamento; CNPJ; Inscrição Estadual. Avaliação de desempenho do fabricante/ distribuidor: Prazos de entrega; Condições de transporte; registrar as não conformidades no momento da entrega.

- How much: quanto custa - Negociações de preços dos medicamentos tendem a reduzir conforme o volume da compra efetuada. A opção por contratos de compra com volume maior, com prazo determinado e entregas parceladas costumam apresentar vantagens como regularidade no abastecimento, redução dos estoques e nos custos de armazenamento, garantia de medicamentos com prazos de validade favoráveis e execução financeira planejada e gradual (CRF/PR, 2012).

- How: como compra - considerando a modalidade de compra?

Uma instituição de caráter privado possui mais autonomia para definir sua programação de estoque e geralmente está baseada na classificação ABC dos medicamentos. Já a administração pública direta

ou indireta deve realizar as suas compras por meio de um processo licitatório, o que é posto pelo art., 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988, que estabelece:

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

A lei 8666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essas compras devem garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (artigo 3º).

Os tipos de licitação são estabelecidos conforme o valor total da compra. Sobre o assunto é válido ressaltar que no ano de 2018 os valores que definiam cada modalidade sofreram atualizações. Sendo elas, conforme redação da lei 8666/93:

■ Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Para compras e serviços, que não sejam de engenharia ou componham obras, o valor total deve ser superior a R\$ 650.000,00.

■ Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Para compras e serviços, que não sejam de engenharia ou componham obras, o valor total deve ser até R\$ 650.000,00.

■ Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. Para compras e serviços, que não sejam de engenharia ou componham obras, o valor total deve ser até R\$ 80.000,00.

■ Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

■ Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Por exemplo: recentemente presenciamos na mídia o leilão do Pré-Sal.

A lei 8666/93 ainda estabelece duas outras modalidades de compra: dispensa de licitação e inexigibilidade.

A dispensa de licitação, também denominada de compra direta, é realizada por meio de pesquisa de preço, conferência de documentações técnicas e fiscais da empresa, e **NECESSARIAMENTE** deve cumprir com algum dos incisos do artigo 24 dessa lei. Dos incisos, damos destaque ao II que se refere às compras de bens e serviços no limite total de R\$ 15000,00 e ao inciso IV que firma:

"IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos".

Esses dois incisos são especialmente importantes porque são os que, usualmente, as pessoas tentam utilizar para fugir de licitações. O valor de R\$ 15.000,00, por exemplo, é fixado para uma rubrica contábil durante um período fiscal (1 ano). Ou seja, após "estourar" esse valor não se pode comprar mais daquele tipo de material por dispensa de licitação.

Em relação ao inciso IV, a interpretação dada por certos profissionais dos casos de emergência e calamidade pública é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Por exemplo, não é emergência ou calamidade pública a compra de notebooks para determinado certo administrativo (comum) com a justificativa que seus computadores de 5 anos de idade estão velhos, porém funcionando. É uma emergência a compra de um medicamento não padrão para um paciente que tem o risco iminente de morrer porque o medicamento é não padronizado e a infecção que esse paciente tem é resistente a todos os antibióticos padrão do hospital. É calamidade pública quando chuvas torrenciais causam destelhamentos e deslizamentos de terra causando a morte ou desalojamento de 50% de uma cidade.

A inexigibilidade de licitação ocorre quando não houver possibilidade de competição. Por exemplo: em Curitiba a única empresa que distribui energia é a Copel, logo, é contratada por inexigibilidade pelos órgãos públicos. Já, os serviços de telefonia podem ser fornecidos por mais de uma empresa e é um serviço comum, logo deve ser adquirido por licitação.

Sobre a inexigibilidade destaca-se o inciso I que tem como redação:

"para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;"

É recomendável que se o solicitante argumentará a justificativa de compra por esse inciso, seja agregado ao processo de compra evidências econômicas e científicas que aquilo é benéfico a administração. Por exemplo: equipamento x apresenta a tecnologia de realizar exames laboratoriais a seco, enquanto no mercado outras marcas utilizam solventes orgânicos. O equipamento X em relação ao restante apresenta as especificações técnicas que são superiores ao restante. Estudos de revisão sistemática informam que o equipamento x é superior.... O custo da aquisição por comodato do equipamento X é maior que do restante, porém se torna menor em tantos % se for analisado o custo para o tratamento do lixo químico.

Apresentando esses argumentos e que eles sejam escritos de maneira clara de modo que qualquer um possa entender, facilita para que os Tribunais de Conta possam aprovar os resultados desses órgãos. É bastante importante lembrar que ao escrever esses documentos, o técnico tenha em mente que quem irá lê-lo é um administrador, um contador ou um advogado que não tem conhecimento de jargões científicos comumente utilizados na área da saúde.

Mais tarde, por meio da lei 10520/2002, outra modalidade de licitação foi estabelecida: o pregão. Deve ser empregado para a aquisição de bens e serviços comuns, isto é, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

O pregão surgiu como uma oportunidade de realizar compras por meio de licitação mais rapidamente. É claro que a velocidade depende também do trâmite e do excesso de burocracia da instituição hospitalar.

O Tribunal de Contas Federal recomenda que o pregão seja realizado por via eletrônica, a fim de evitar conluio entre os participantes, já que abrange não só fornecedores locais. O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet. Essa modalidade é regulamentada pelo decreto 5.450/2005.

Além disso, também é recomendável que sejam feitas compras pela modalidade de registro de preços que é um tipo especial de licitação, realizada obrigatoriamente nas modalidades de Concorrência ou Pregão (para bens e serviços comuns). Ao final de uma concorrência ou de um pregão, é feita uma Ata de Registro de Preços. Na Ata de Registro de Preços são averbados os bens, os preços, os fornecedores e as condições das futuras contratações. Os produtos os serviços contidos nela ficam disponíveis a administração por um período de 12 meses que serão requisitados se e quando forem necessários. Deve-se pesquisar, ao realizar a solicitação do produto ou serviço, se o valor contido em ata é compatível ao mercado. *Caso o preço do item registrado esteja maior que o praticado no mercado, o fornecedor deve ser comunicado e o preço deve ser reduzido, sob pena de o registro ser cancelado* (TCU, 2015).

O não cumprimento do disposto na lei gera desde processos administrativos e disciplinares até processos civis e penais que podem levar desde suspensões, exonerações, multas, devolução de valores até prisão.

Essas modalidades de compra são feitas por meio de um processo, que dentre outros documentos, deve conter: Solicitação da compra; justificativa para aquisição; Pesquisa de preço e tabela comparativa de resultados contendo a média ou mediana; Termo de referência; autorizo conforme disposto em lei; Termo de referência.

A pesquisa de preço deve ser realizada com pelo menos três fornecedores e pode abranger os resultados de atas de registro de preço (geralmente com até 6 meses de emissão), resultados de compras anteriores, bancos de preço e listagens governamentais.

Nesse sentido é importante conhecer:

- Painel de Compras do Governo Federal: ferramenta que os principais números das contratações públicas e tem por finalidade oferecer um panorama dos gastos públicos e do comportamento licitatório no âmbito da Administração Pública Federal. Link: <http://bit.ly/2l6m34N>

- Lista CMED: apresenta o valor máximo permitido para a venda de medicamentos, atualizada mensalmente, tanto para consumidores comuns como para compras governamentais. Link: <http://bit.ly/2l6m34N>

- Banco de preços em Saúde: sistema criado pelo Ministério da Saúde com objetivo de registrar e disponibilizar on line as informações das compras públicas e privadas de medicamentos e produtos para a saúde. Link: <http://bit.ly/2TdOsuz>

- Tabela SIGTAP: Sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS – apresenta o valor máximo pago pelo SUS. Link: <http://bit.ly/38mZZhI>

Os planos de saúde também detêm tabelas de valores máximos para procedimentos, medicamentos e OPME que pagam aos seus parceiros. Elas seguem parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, conforme o padrão TISS (Troca de Informação de Saúde Suplementar – ANS)

Vamos voltar ao termo de referência. Esse é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

Esse documento é extremamente importante para a execução da compra. É por meio dele que o solicitante pode descrever as especificações técnicas do produto (não pode favorecer a alguma marca, eiii!), a maneira que será fornecido, se haverá necessidade de amostra e de que forma essa amostra será analisada (geralmente anexa-se um checklist e lembrando que a análise deve poder ser acompanhada por todos os fornecedores), quais os documentos técnicos que serão exigidos da empresa para comprovar a sua qualidade.

Para as compras públicas deve-se entender que é o termo de referência que vai dizer o que vai ser comprado. Ao mesmo tempo que não se pode tender a determinado fornecedor, também não se pode deixar a descrição do objeto genérica. Quando a descrição é malfeita, o produto é igualmente ou pior a ela e não adianta dizer depois que “isso não foi o que pedi” porque era aquilo que estava escrito. Sempre se lembre que o fornecedor sempre tentará puxar para o seu lado visando o lucro, se a descrição for ruim, tentará ganhar pelo menor preço e com a maior faixa de lucro possível.

SAIBA MAIS:

Para conhecer e se aprofundar mais na compra pública de medicamentos aconselho que procure as orientações para compra da sua instituição, do Tribunal de Contas da União, do seu Estado e Município, conforme for a esfera que trabalha. Como nenhuma orientação de esferas estaduais ou municipais podem ir contra ao estabelecido pela federal, apresento alguns documentos para complementar o seu conhecimento.



■ Orientações para aquisições públicas de medicamentos: <http://bit.ly/3c1dJAZ>

■ Manuais do Pregão Eletrônico e das Compras Diretas: <http://bit.ly/2T8TpF6>

■ Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU: <http://bit.ly/2HSwkkL>

No contexto da aquisição de produtos para saúde e medicamentos, a falta de planejamento, de falta de medicamento, de falta de solicitações de compra, entre outras tantas faltas, pode ocasionar o comprometimento da saúde, agravamento de doenças, diminuição da qualidade de vida e, até mesmo, a morte de um ser humano, o paciente para o qual você é responsável. Assim, não se esqueça que informações corretas permitem o planejamento correto da programação de compra, da aquisição e seu recebimento.

REVISANDO:

E aí, querid@ alun@! Aprendeu tudo? Apesar de muitos detalhes, a etapa de aquisição é essencial para que tudo aconteça, desde que a programação e a seleção sejam bem-feitas. Nessa competência pudemos ver como deve ser definida a compra – ferramenta 5W2H, de que modo a etapa de programação influencia na etapa de aquisição. Além disso, conhecemos as modalidades de compras públicas, a importância do termo de referência e onde realizar a pesquisa de preços. Sempre lembrando que se for servidor público ou equipara-se a um deve prestar muita atenção às leis, pois seu nome constará nos documentos. Além disso, olho aberto, o pregoeiro (aquele que executa de fato o pregão) responde como pessoa civil às compras que faz. Ou seja, caso haja alguma coisa de errado ou duvidosa quem arca com as consequências é ele, mesmo que o que ele fez seja fruto de distração.

Aprendendo a como e por que armazenar corretamente

INTRODUÇÃO:

Olá! Nessa competência conheceremos o que acontece depois que compramos os medicamentos e os produtos para a saúde. As condições de armazenamento são muito importantes durante o transporte e estocagem para que tanto medicamentos e insumos quanto os produtos para a saúde mantenham as suas características e qualidade, como quando foram embalados. Assim, zelar pelo que se tem para que não haja perdas e geração de um prejuízo evitável.

Armazenamento e conservação

O recebimento das mercadorias após a aquisição precede o armazenamento na instituição. Essa sub etapa pode ser descrita como "a verificação dos aspectos administrativos e requisitos técnicos dos produtos entregues, e ainda, a elaboração dos informes de ingresso"

(CRF/PR, 2012). Recomenda-se que haja uma área exclusiva para esse fim, para que os produtos fiquem em "quarentena" enquanto não recebem o ok para serem armazenadas no estoque. Devem ser observados: quantidade; lote; embalagens; validade; registro na ANVISA/MS ou presença de expressões como "Produto Notificado na ANVISA/MS" e "Declarado Isento de Registro pelo Ministério da Saúde". Ainda, vencedores de licitação devem apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDO A VENDANO COMÉRCIO".

Recomenda-se também que inspeções visuais sejam realizadas em amostras aleatórias como presença de corpo estranho em medicamentos ou insumos para infusão intravenosa (ex. cristais, lascas de vidro, hifas), estado de embalagens de produtos estéreis e dureza de comprimidos.

Além disso, deve-se garantir que as condições do transporte sejam ideais para manter a qualidade dos produtos. Os veículos devem ser apropriados, higienizados, com sistema de manutenção e controle de temperatura, umidade adequada ao tipo de produto transportado, sem contato com outros produtos incompatíveis com o transporte de medicamentos e produtos para saúde. As não conformidades devem ser verificadas e formalmente notificadas à empresa e no cadastro de fornecedores da instituição, podendo, se for evento recorrente, ser motivo para desclassificação em nova licitação, por exemplo.

O armazenamento correto durante o transporte, recebimento ou estocagem deve garantir a manutenção da qualidade física e microbiológica dos produtos, além de evitar perdas por vencimento. Isto é, armazenar corretamente, promove conservação. Conservar medicamentos é manter os produtos em condições satisfatórias de estocagem para manutenção de sua estabilidade e integridade durante o período de vida útil.

A estabilidade diz respeito ao período no qual o produto mantém - dentro de limites estabelecidos e sob determinadas condições ambientais - as mesmas características físicas, químicas e farmacológicas, durante seu período de vida útil. Esse espaço de tempo, no qual se assegura sua integridade, representa o período de validade. As alterações físicas, tais como a mudança de cor, odor, precipitação, turvação, servem de alerta, indicando sinais de instabilidade no medicamento.

Os fatores que alteram a estabilidade dos medicamentos podem ser intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos estão o relacionados ao processo de fabricação do medicamento: procedimentos, métodos, técnicas, equipamentos, envase, embalagens, princípios ativos e inativos (excipiente, conservantes, corantes e aromatizantes), interações entre os fármacos, e fármacos e solventes ou adjuvantes, pH do meio, tamanho das partículas, alteração nos aspectos físicos (precipitação, presença de gases, uniformidade da dose, recipientes e grau de impurezas), incompatibilidades e outros. Enquanto os extrínsecos estão relacionados às condições ambientais (temperatura, ventilação, luminosidade e umidade), às condições e técnicas de armazenagem, ao manuseio, ao transporte, à higienização (poeira e contaminantes) etc.

Segundo CRF/PR (2012), *“o armazenamento racional contribui para a saúde financeira da instituição e a segurança ao paciente, este pressupõe: dimensionamento da área física; infraestrutura (área física, equipamentos e recursos humanos) e processos”*. A diminuição de custos também é discutida por outros autores, de modo a evitar desperdícios no ambiente hospitalar.

Ainda, sobre o assunto, Cavallini e Bisson (2010) afirmam que: “um método adequado para estocar materiais, medicamentos e produtos manipulados na farmácia hospitalar permite diminuir os custos de operação, melhorar a qualidade dos serviços e acelerar o ritmo do trabalho, garantindo também a diminuição dos acidentes de trabalho, a redução no desgaste dos demais sistemas (dose unitária, manipulação, farmácias-satélites) e um menor número de problemas de administração.”

O TCU também sugere métodos para a manutenção de estoques, de forma a minimizar os gastos, sobretudo os gastos públicos. Para o TCU (2015), *minimizar os estoques de medicamentos e maximizar seu giro tem-se mostrado uma prática que torna mais eficientes o armazenamento e a distribuição de remédios, razão por que é importante a existência de algum tipo de controle de estoque periódico*.

A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é a unidade de assistência farmacêutica que serve para a guarda de medicamentos e correlatos. Nela são realizadas atividades quanto à correta recepção, estocagem, controle e distribuição de produtos. As técnicas utilizadas para o armazenamento na CAF devem obedecer às regras específicas da manipulação e estocagem de medicamentos. De acordo com o tamanho do hospital, pode haver mais de uma central de armazenamento e distribuição de medicamentos e produtos para saúde.

A infraestrutura da área de armazenamento deve seguir recomendações da RDC n° 50, de 21/02/2002 da ANVISA, que prevê 0,6m² para cada leito hospitalar. Ainda, dependendo do porte do hospital, a estocagem pode ser realizada de forma centralizada ou descentralizada, mas sempre respeitando as especificações do fabricante e das boas práticas de armazenamento.

O modo como esse espaço é organizado é importante para que haja máximo rendimento e maior economia. O layout depende de fatores como o local selecionado, o projeto de construção (especialmente relevante se não houver a possibilidade de alterações), equipamentos utilizados, atendimento e natureza dos produtos estocados. Para melhores escolhas, sugere-se estudos de layout empregando ferramentas do *lean manufacturing*.

As áreas de armazenagem de medicamentos precisam ser definidas e adaptadas de acordo com um projeto técnico adequado. Assim, de modo a seguir a RDC 50, layout que promova eficiência e as Boas Práticas para estocagem de medicamentos do Ministério da Saúde (1989).

A armazenagem de medicamentos nunca deve ser realizada diretamente no solo, de modo a utilizar pallets, armários ou prateleiras de acordo com a dimensão e as características do próprio material ou produto. As características das formas de armazenagem mais comuns são:

- Caixas: adequadas para itens de pequenas dimensões
- Prateleiras: fabricadas de madeira ou perfis metálicos, destinam-se ao armazenamento de peças maiores ou ao apoio de gavetas ou caixas padronizadas. Sendo preferíveis as metálicas devidamente tratadas, considerando a possibilidade de insetos se multiplicarem no material orgânico (ex. cupins) e contaminar os produtos com celulose.

- Racks: são construídos para armazenar peças longas e estreitas.
- Empilhamento: constitui uma variante do armazenamento de caixas e de certos produtos, formando uma prateleira por si só.
- Refrigeradores: destinados a produtos termolábeis (e nada de alimentos!).

O local de armazenamento deve ser seguro, de fácil acesso, porém de acesso restrito a pessoas não autorizadas. Preferencialmente com rampa de acesso ao nível da rua para carga e descarga. Os corredores devem permitir circulação fácil. As paredes – cor clara, pintura lavável, isentas de infiltrações e umidade.

O topo das pilhas não deve encontrar-se a uma distância menor que um metro dos sprinklers e sempre deve observar-se o empilhamento máximo. Para prevenção de incêndios pode preferir-se por extintores e contar com a manutenção permanente da rede elétrica para evitar curto-circuito

As portas devem ser esmaltadas ou de alumínio e ter largura suficiente para permitir a passagem de carrinhos de transporte. O piso deve ser plano, resistente, liso e de concreto, preferencialmente pintados com tinta epóxi para alto tráfego para permitir limpeza adequada do local.

O local de estocagem deve ter ventilação adequada, com circulação de ar, porém janelas devem, preferencialmente, apresentar telas para prevenir insetos e outras pragas. Além disso, a luz solar não deve incidir diretamente sobre o local.

A temperatura ambiente deve ser mantida em torno de 20 °C (com variação de 2 °C), com refrigerador (de 4 °C a 8 °C) para produtos termolábeis. A temperatura é uma condição ambiental diretamente responsável por grande número de alterações e deteriorações nos medicamentos. O aumento da temperatura causa a aceleração de átomos em nível molecular, o que leva a indução de reações químicas e decomposição da matéria.

Alguns produtos necessitam de armazenamentos diferenciados para se manterem estáveis e para a manutenção de sua qualidade. São produtos sensíveis às variações de temperatura. Algumas zonas de temperatura são preconizadas:

- temperatura ambiente: entre 15°C e 30°C;
- local fresco: entre 8°C e 15°C (área de estocagem geral);
- refrigerador: entre 2°C e 8°C;
- congelador: entre 0°C e -20°C.

A umidade do ambiente também deve ser controlada por meio de higrômetros, de forma a não ultrapassar 70%. A alta umidade favorece o crescimento de fungos e bactérias, que contaminam o ambiente e podem deteriorar os medicamentos.

Cavallini e Bisson (2010) informam que a área de estocagem propriamente dita deve apresentar: área distinta para medicamentos e correlatos; área fechada a chave para psicotrópicos; fácil acesso para os funcionários; distribuição racional e adequada; prateleiras amplas, claras e espaçadas; iluminação adequada; extintores bem localizados.

Os medicamentos relacionados na Portaria SVS/MS no 344, da ANVISA, por serem considerados capazes de causar dependência física e/ou psíquica, devem ser armazenados em local seguro, de preferência em uma área com fechamento (trancas, cadeados) e separados dos demais medicamentos.

Enquanto os quimioterápicos devem ser armazenados conforme o disposto pela RDC no 220/2004 da ANVISA. Esses produtos são citotóxicos e devem ser armazenados em área restrita, destinada apenas para esse fim. Um kit antiderramamento deve estar disponível e conter todos os equipamentos de proteção individual e material necessário para a limpeza, em caso de acidente. Os funcionários devem ser treinados para se paramentarem, isolar a área e fazerem a assepsia do local.

Os equipamentos devem ser, sempre que possível, aparelhos de ar condicionado, armários com chave, carrinho de transporte, cestas de marfinito, caixas plásticas, empilhadeiras, exaustores, termômetros, higrômetros, geladeiras e freezers.

Agora que conhecemos a área física e equipamentos, vamos falar sobre a organização. O estoque deve elaborar um sistema de localização e identificação de materiais organizado, que facilite a busca deles no menor tempo possível. Os materiais devem ser codificados e apresentados em um sistema que garanta a perfeita localização dos materiais estocados sob a responsabilidade do almoxarifado.

Cada conjunto de códigos deve indicar com precisão a posição de cada material estocado, de modo que se facilitem as operações de movimentação, inventário etc. As estantes podem ser identificadas por letras, cores, números etc. O objetivo dessa classificação de materiais é estabelecer, por meio de códigos, a catalogação de todos os materiais que compõem o estoque da empresa.

Periodicamente, a empresa deve efetuar contagens físicas de seus itens de estoque para verificar: discrepâncias em valor, entre o estoque físico e o estoque contábil; discrepâncias entre os registros; apuração do valor total do estoque para efeitos de balanços; neste caso, o inventário é realizado próximo ao encerramento do ano fiscal.

A organização do estoque deve levar em consideração a facilidade para o acesso aos itens e para a sua distribuição, deixando sempre mais próximo à área de saída do estoque (fácil acesso) os medicamentos mais utilizados e de maior rotatividade. É importante garantir que o item com menor prazo de validade fique armazenado à frente dos itens com prazo maior e preconizado que os itens com menor validade fiquem à esquerda dos demais. Para isso a metodologia FIFO (first in, first out) ou PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair) deve ser adotada.

A recepção e o armazenamento se tornam críticos para garantir que os produtos comprados mantenham a qualidade até chegar no paciente. Medicamentos vencidos ou com a estabilidade alterada pode levar a falta de eficácia, causar reações no paciente e piorar a sua qualidade de vida ou enfermidade.

RESUMINDO:



E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo desta unidade letiva, vamos resumir tudo o que vimos. Nesta Unidade Letiva você teve a oportunidade de conhecer qual a importância e o procedimento para a seleção e padronização de medicamentos. Também vimos modos de planejar a quantidade e a programação de compra, como são os modos de aquisição e como devem ser armazenados os medicamentos e produtos para saúde. Ufa! Por hoje é só pessoal! Até o próximo episódio.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 20 anos do SUS. Legislação. Disponível em: <http://bit.ly/2Shd86v>

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização Brasília: Ministério da Saúde, 2 ed., 2006.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Básico para Farmácia Hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. Disponível em: <http://bit.ly/390Bckk>

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Resolução 338, de 06 de maio de 2004. Disponível em: <http://bit.ly/2Z8VogO>

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência Farmacêutica: instruções técnicas para a sua organização. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boas práticas para estocagem de medicamentos. Brasília: Central de Medicamentos, 1989. Disponível em: <http://bit.ly/2PnitqQ>

BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Orientações para conselheiros de saúde. Brasília: TCU, 2 ed., 2015.

CARVALHO, F. D. et al. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, habilidades e atitudes. São Paulo: Manole, 2014.

CAVALLINI, M. E.; BISSON, M. P. Farmácia Hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde. São Paulo: Manole, 2 ed., 2010.

CHIAVENATO, I. Desempenho humano nas empresas: como desenhar cargos e avaliar o desempenho para alcançar resultados. São Paulo: Manole, 9 ed., 2009.

DANTAS, S. C. C. Farmácia e Controle das Infecções Hospitalares. Pharmacia Brasileira, n 80, fev./mar., 2011. Disponível em: <http://bit.ly/2Sa3G54>

JULIANI, R. G. M. Organização e funcionamento de farmácia hospitalar. São Paulo: Érica, 2014.

MÁLAGÓN-LONDOÑO, G. et al. Gestão Hospitalar para uma administração eficaz. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 4 ed., 2019.

SIMONETTI, V.M.M.; et al. Gestão de suprimentos da farmácia hospitalar com a implantação de métodos gerenciais de insumos

utilizados na manufatura. Revista Eletrônica Produção Engenharia v.2 n.1 p. 57 68. jan.-jul., 2009.

SALU, E. J. Administração Hospitalar no Brasil. São Paulo: Manole, 2013.
Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH). Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar. São Paulo: SBRAFH, 3 ed., 2017. Disponível em: <http://bit.ly/2EIJTL2>

